

A) Beta lactamines ou Antibiotiques betalactames(Famille) :

1)Amoxicilline(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(sphereORL:Otite-Sinusite-pharyngite- ;Angine ;Toux grasse)
- Abcet dentaire
- Cas postopératoire(comme prevention)
- infection digestif(Ulcère gastrique)

FDP :

-CP,gel { 500mg : (Enf+12ans)
1g :Ad } → 1cp---2→3*/jour

-SP { 125mg :NRS
250mg :Enf(2→6ans)
500mg :Enf(6→12ans) } → 1C a M---2→3*/jour

-INJ { 500mg : (Enf+12ans)
1g :Ad } → 1inj en IM/jour(N7→N10)

NC :Clamoxyl ;amoxypen ;Amodexgé ;Biopamox ;Amoximex ;lamoxyl ;Saiffoxyl ;Penamax

2)Ampicilline(DCI) :

Ind :

- Infection urogénital(++++)
- infection respiratoire
- cas post-opératoire

FDP :

- gel 500mg { Enf+12ans:1gel---2 → 3*/jour
Ad :2gel---2 → 3*/jour

-SP 250mg :Enf(2-6ans) :1C a M---2 → 3*/jour

-INj 1g :Ad---1inj en IM/jour

NC :Totapen ;Ampal ;Ampilline ;Ampinax

3) « Amoxicilline+Acide clavulanique »(DCI) :

Ind :

-Infection respiratoire aigue(Bronchite,sphere ORL,Angine)

-Abcet dentaire

-Infection urinaire

FDP { 500mg :(Enf+12ans)
-CP { 1g : Ad } } 1cp---2 → 3*/jour

-ST { 500mg :Enf
1g : Ad } } 1sac---2 → 3*/jour

-SP { NRS
Enf } } 1ddp---2 → 3*/jour

NB :concernent les SP(NRS,Enf),il ya aucune différence entre eux, sauf dans la quantité(30ml vs 60ml ou 35ml vs 70ml);donc ,on peut donner le SP de NRS a l'Enf et vice versa, en considération du poids du malade

NC :Augmentin ;Augmentimex ;Klavox ;Amoclan BID ;Amoclan 8 :1 ;Bioclav ;clavodar

4)Oxacilline(DCI) :

Ind :

-Infection cutanée(plais,Abcet cutanée)

FDP : $\left. \begin{array}{l} \text{Enf+12ans :1gel} \\ \text{-gel} \\ \text{Ad : 2gel} \end{array} \right\} 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

-INJ $\left[\begin{array}{l} 500\text{mg} \\ 1\text{g} \end{array} \right] \text{Ad :1inj en IM/jour}$

NC :Bristopen ;Oxacil ;Oxaline ;Oxal ;Oxcare

5)Phenoxyl-Methyl-Penicilline « PMP »(DCI) :

Ind :

-Angine(traitement pde 10 jours)

FDP : $\left. \begin{array}{l} 1\text{MUI : (Enf+12ans)} \\ \text{-CP} \\ 1,5\text{MUI :Ad} \end{array} \right\} 1\text{cp} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

-SP $\left\{ \begin{array}{l} 250\ 000\text{UI : (Enf+3ans) :1C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour} \\ 400\ 000\text{UI (très rare)} \end{array} \right.$

-INJ $\left. \begin{array}{l} 500\ 000\text{UI :Enf} \\ 1\text{MUI :Ad} \end{array} \right\} 1\text{inj en IM/jour}$

NC : Ospan ; Orapen ; Penival ; gectapen

6) Benzathine penicilline(DCI) :

Ind :

-Angine(effet retard :traitement peut atteindre 5 mois)

FDP : $\left\{ \begin{array}{l} 600\ 000\text{UI} : \text{Enf} \\ 1,2\text{MUI} : \text{Ad} \end{array} \right\}$
-INJ $\left\{ \begin{array}{l} 600\ 000\text{UI} : \text{Enf} \\ 1,2\text{MUI} : \text{Ad} \end{array} \right\}$ } 1inj/21jours(on a dit : effet retard,,,N°07 « presque 4 mois »)

NC : Extencine ; Extencilline ; Retarcilline ; Retarmex ; Retarpen

B) Les céphalosporines(Famille) :

1) Cefalexine(DCI) :

Ind :

-infection respiratoire(sphere ORL ; Angine ; Bronchite)

-cas post-opératoire(++++)

-infection urogénital

-infection dermatologique (varicelle « بوشوكة »)

FDP : $\left\{ \begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf}+12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right\}$
-CP $\left\{ \begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf}+12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right\}$ } 1cp---2→3*/jour

-SP $\left\{ \begin{array}{l} 125\text{mg} : \text{NRS} \\ 250\text{mg} : \text{Enf} \end{array} \right\}$ } 1C a M---2→3*/jour

NC : Keforel; lexinal; lexin ; cephalax; Cephadar ; Cefadat ; Ospexin ; ulexin